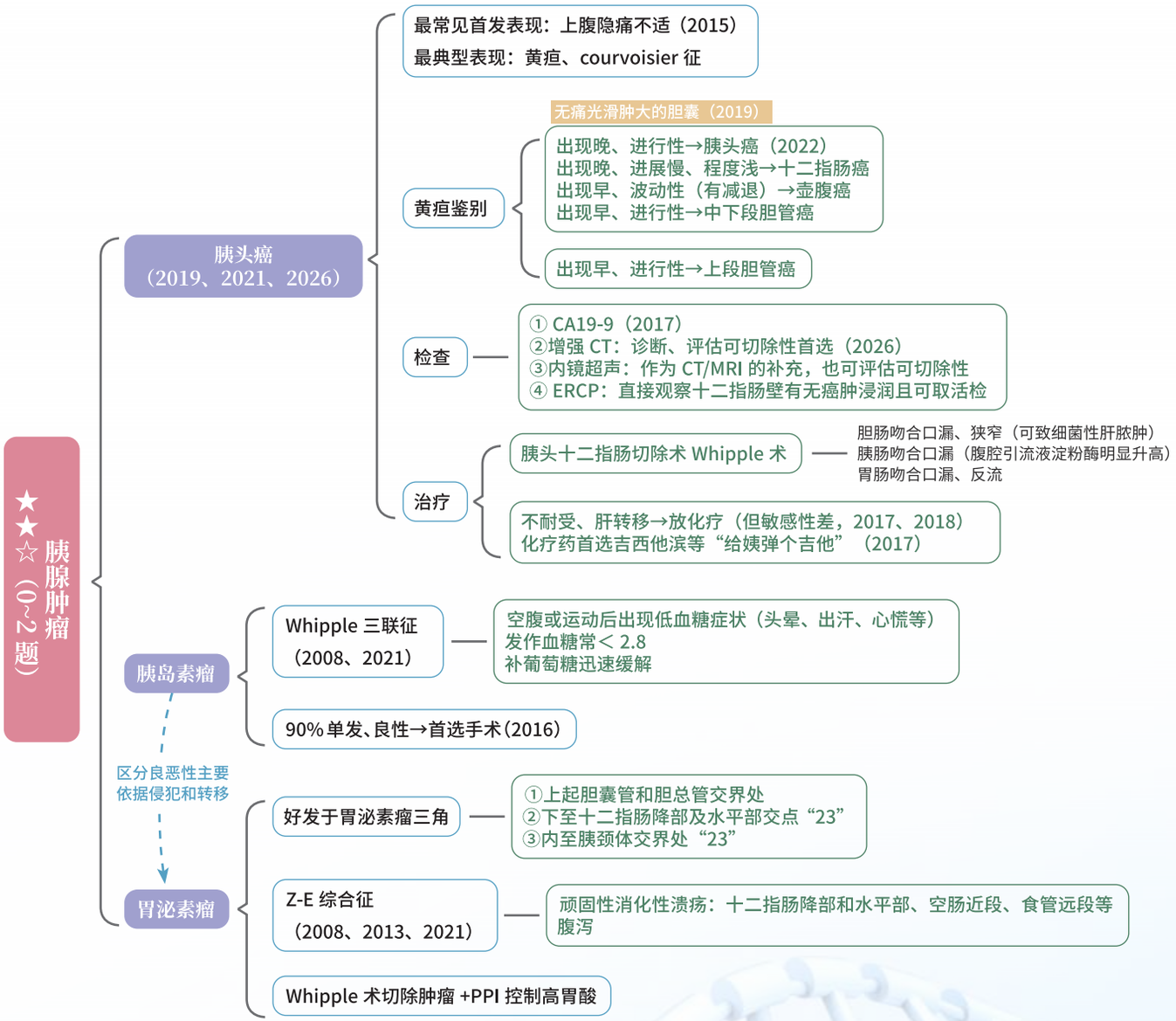

★★☆胰腺肿瘤（0~2题）
胰头癌（2019、2021、2026）
最常见首发表现：上腹隐痛不适（2015）
最典型表现：黄疸、courvoisier 征
黄疸鉴别
无痛光滑肿大的胆囊（2019）
出现晚、进行性→胰头癌（2022）
出现晚、进展慢、程度浅→十二指肠癌
出现早、波动性（有减退）→壶腹癌
出现早、进行性→中下段胆管癌
出现早、进行性→上段胆管癌
检查
① CA19-9（2017）
②增强 CT：诊断、评估可切除性首选（2026）
③内镜超声：作为 CT/MRI 的补充，也可评估可切除性
④ ERCP：直接观察十二指肠壁有无癌肿浸润且可取活检
治疗
胰头十二指肠切除术 Whipple 术
胆肠吻合口漏、狭窄（可致细菌性肝脓肿）
胰肠吻合口漏（腹腔引流液淀粉酶明显升高）
胃肠吻合口漏、反流
不耐受、肝转移→放化疗（但敏感性差，2017、2018）
化疗药首选吉西他滨等“给姨弹个吉他”（2017）
胰岛素瘤
Whipple 三联征（2008、2021）
空腹或运动后出现低血糖症状（头晕、出汗、心慌等）
发作血糖常＜2.8
补葡萄糖迅速缓解
90% 单发、良性→首选手术（2016）
区分良恶性主要依据侵犯和转移
胃泌素瘤
好发于胃泌素瘤三角
①上起胆囊管和胆总管交界处
②下至十二指肠降部及水平部交点“23”
③内至胰颈体交界处“23”
Z-E 综合征（2008、2013、2021）
顽固性消化性溃疡：十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段等
腹泻
Whipple 术切除肿瘤 +PPI 控制高胃酸